طبع فى 23:33:09 24/10/2026

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عايده محمد السيد احمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** كرداسه **العنوان :** بني مجدول
رقم البطاقة : 27509142102783 **رقم التليفون :** 01150410876 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 14-09-1975 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: عايده محمد السيد احمد
National ID: 27509142102783

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bone scintigraphy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
عايده
محمد السيد أحمد عيسى البطاوى
قرية بنى مجدول
مركز كرداسة - الجيزه
٢٧٥ ٠٩١٤٢١ ٠٢٧٨٣
MA7555734



National ID – Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

||DOCTYPE:PATHOLOGY REPORT||
Pathology Report

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: عايده محمد السيد احمد	**Age: 51 years** **Sex**: female
Request type: مبادره	**Sub request type:**
Hospital no:	**Pathology no.**:1032B-2026
Department:صحه مرأه	**Date of result:**29/9/2026
Referred by: د/ايمان عادل	**Date of biopsy:**22/9/2026
Nature of specimen:tru-cut biopsy	**I.D. Number:**27509142102783

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Pan CK- P63- ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result

Pan CK: positive in tumor cells
P63: Lost in tumor cells
ER: No nuclear staining of tumor cells (Allred Score 0/8) Negative.
PR: No nuclear staining of tumor cells (Allred Score 0/8) Negative.
Her2: Strong complete membranous staining in >10% of tumor cells (score 3+) positive.
Ki67: Positive nuclear staining of 40% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass ,Tru-cut biopsy :
Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

اسم المريض بالإنجليزية: Aidah Mohamed Alsid Ahmed	كود المريض: 99681
تاريخ التقرير: 2026/09/15 01:10:56 PM	السن: ٥١ سنة

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 50 y old lady coming for right breast inflammatory changes.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Heterogeneously dense breast (ACR c), which may obscure small lesion.
- No suspicious masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- UOQ posterior third oval circumscribed density, correspond to IMLN , confirmed by US, showing preserved hilum
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Right breast

- Heterogeneously dense breast (ACR c
- Diffuse focal asymmetry seen mainly at UOQ, retro areolar lower outer &midline, as well as UIQ, with diffuse coarse heterogeneous calcifications seen within, extending in anterior, middle and posterior thirds.
- Axillary tail lobulated mildly dense lesion
- Diffuse skin thickening with mild nipple retraction
- **Ultrasound** demonstrated diffuse parenchymal distortion, seen mainly at OQ, retro areolar region extending to UIQ.
- Diffuse skin thickening reaches up to 5 mm.
- LEVEL I pathological axillary LN measures 30 x 20 mm, with diffuse cortical thickening reach up to 9 mm.
- No infra or supra clavicular lymph nodes

Impression:

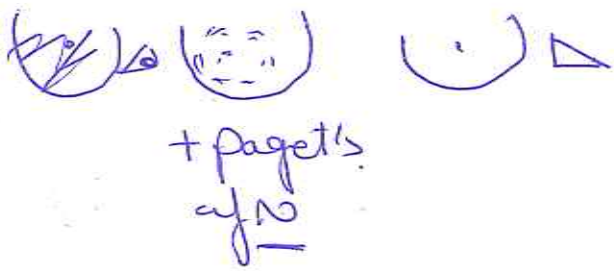
Left breast (BIRADS 2): UOQ IMLN

Right breast (BIRADS 4C): Suspected locally advanced malignant process, with ipsilateral pathological level I axillary lymph node

Recommendations:

For sonar guided biopsy.

Dr RANIA AHMED, MD







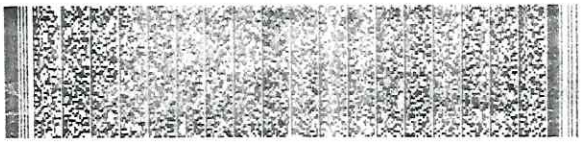
٢٧٥٠١٠٢١٠٢٧٨٣ ٢٠١٩/١٠

ربة منزل

انثى مسلمة متزوجة

مجدى احمد حفنى سيد احمد

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/١٠/١٥



١١٥٠٤١٠٨٧٦

١١٢٧٢٠٢٦٢٥ عينة



جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق شخصية

عابده

محمد السيد احمد عيس الشاوى

بنى عبدول

مركز كرداسه - الجيزه

٢٧٥٠٩١٤٢١٠٢٧٨٣

IE9260452

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار :فرع الجيزة

تاريخ الاصدار :2026-9-21

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) عايده محمد السيد احمد عيسى بطاقة رقم 27509142102783

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2026-9-21

الموظف المختص

احمد ياسر

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2085252

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: عايده محمد السيد احمد
Age: 51 years
Sex: female
Request type: مبادره
Sub request type:
Hospital no:
Pathology no.:1032B-2026
Department:صحه مرأه
Date of result:29/9/2026
Referred by: د/ايمان عادل
Date of biopsy:22/9/2026
Nature of specimen:tru-cut biopsy
I.D. Number:27509142102783
Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Pan CK- P63- ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result

Pan CK: positive in tumor cells
P63: Lost in tumor cells
ER: No nuclear staining of tumor cells (Allred Score 0/8) Negative.
PR: No nuclear staining of tumor cells (Allred Score 0/8) Negative.
Her2: Strong complete membranous staining in >10% of tumor cells (score 3+) positive.
Ki67: Positive nuclear staining of 40% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Aidah Mohamed Alsid Ahmed :اسم المريض بالإنجليزية	كود المريض: 99681
2026/09/15 01:10:56 PM :تاريخ التقرير	السن: ٥١ سنة

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 50 y old lady coming for right breast inflammatory changes.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Heterogeneously dense breast (ACR c), which may obscure small lesion.
- No suspicious masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- UOQ posterior third oval circumscribed density, correspond to IMLN , confirmed by US, showing preserved hilum
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Right breast

- Heterogeneously dense breast (ACR c
- Diffuse focal asymmetry seen mainly at UOQ, retro areolar lower outer &midline, as well as UIQ, with diffuse coarse heterogeneous calcifications seen within, extending in anterior, middle and posterior thirds.
- Axillary tail lobulated mildly dense lesion
- Diffuse skin thickening with mild nipple retraction
- **Ultrasound** demonstrated diffuse parenchymal distortion, seen mainly at OQ, retro areolar region extending to UIQ.
- Diffuse skin thickening reaches up to 5 mm.
- LEVEL I pathological axillary LN measures 30 x 20 mm, with diffuse cortical thickening reach up to 9 mm.
- No infra or supra clavicular lymph nodes

Impression:

Left breast (BIRADS 2): UOQ IMLN

Right breast (BIRADS 4C): Suspected locally advanced malignant process, with ipsilateral pathological level I axillary lymph node

Recommendations:

For sonar guided biopsy.

Dr RANIA AHMED, MD



Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]